TEMA 1 · Fundamentos de Enfermería, Modelos teóricos y Constitución

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Historia y profesión · Bloque B: Modelos y teorías · Bloque C: Constitución y Estatuto de Murcia

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
CIE	Consejo Internacional de Enfermeras (1899)	Organización mundial de la enfermería; código deontológico internacional
OMS	Organización Mundial de la Salud	Organismo de la ONU para la salud
ATS / DUE	Ayudante Técnico Sanitario / Diplomado Universitario en Enfermería	Títulos anteriores al actual Grado en Enfermería
EIR	Enfermero/a Interno/a Residente	Vía de formación de las especialidades (2 años de residencia)
RD	Real Decreto	Norma del Gobierno (rango inferior a la ley)
RD 2128/1977	Integración de las Escuelas de ATS en la Universidad	Crea la diplomatura de Enfermería (3 años)
RD 450/2005	Real Decreto de especialidades de Enfermería	Las 7 especialidades
CE	Constitución Española de 1978	Norma suprema del Estado
LO	Ley Orgánica	Ley de mayoría absoluta (derechos fundamentales, Estatutos, régimen electoral)
LO 4/1982	Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia	«Constitución» de la Región
SNS	Sistema Nacional de Salud	Conjunto de los Servicios de Salud del Estado y de las CCAA
CCAA	Comunidades Autónomas	
SMS	Servicio Murciano de Salud	Servicio de Salud de Murcia (gestiona centros y personal)
LGS (Ley 14/1986)	Ley General de Sanidad	Crea el SNS
Ley 16/2003	Ley de Cohesión y Calidad del SNS	Igualdad entre CCAA y cartera de servicios
Ley 33/2011	Ley General de Salud Pública	
Ley 55/2003	Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud	Derechos, deberes y trabajo del personal del SNS
Ley 31/1995	Ley de Prevención de Riesgos Laborales	Desarrolla el art. 40.2 CE
Ley 4/1994	Ley de Salud de la Región de Murcia	Crea el SMS
Ley 6/2004	Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia	Elección y cese del Presidente
Ley 7/2004	Organización y Régimen Jurídico de la Administración regional de Murcia	Órganos superiores y directivos
CES	Consejo Económico y Social (de Murcia)	Órgano consultivo socioeconómico
INGESA	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	Gestiona la sanidad pública en Ceuta y Melilla (Estado)

A1. Historia de la enfermería: las 4 etapas

Etapa	Época	Claves
Doméstica	Prehistoria y civilizaciones antiguas	Cuida la mujer del grupo. Visión mágico-religiosa (chamán). **Paleoenfermería** = estudio de esos cuidados
Vocacional	Cristianismo hasta fin de la Edad Moderna	Cuidar = **caridad cristiana**. La Iglesia asume la atención: monasterios, órdenes religiosas
Técnica	Siglo XIX	Profesionalización laica y primera formación reglada (Fliedner, Nightingale)
Profesional	Siglos XX-XXI	Profesión autónoma: universidad, colegios, especialidades, investigación

Etapa doméstica: civilizaciones antiguas

- **Egipto**: papiro de **Ebers**. Mucha higiene y salud pública; médicos especializados por patologías; partos con comadronas.
- **Mesopotamia**: **Código de Hammurabi** (ca. 1750 a.C.), la primera reglamentación escrita del ejercicio sanitario. **No menciona la enfermería**.
- **Hebreos**: la enfermedad es un castigo divino, pero reconocen el contagio, el aislamiento y la notificación. La **Ley Mosaica** regula la higiene. **Débora** es la primera enfermera reconocida.
- **India**: Vedas (ca. 1600 a.C.). El texto **Kaviratna** dice que los cuidadores deben ser hombres jóvenes (o mujeres ancianas).
- **China**: salud = armonía con el universo, equilibrio **Yin-Yang**.
- **Grecia**: se pasa de una visión teúrgica (la enfermedad la envían los dioses) a una naturalista (tiene causas naturales). **Hipócrates** (s. V a.C.), «padre de la medicina», con la **Teoría Humoral**: la enfermedad es un desequilibrio de 4 humores: **sangre** (caliente y húmeda), **bilis amarilla** (caliente y seca), **bilis negra** (fría y seca) y **flema** (fría y húmeda). Templos de Asclepio.
- **Roma**: medicina militar; los **nosocomi** son los antecesores de camilleros y enfermeros de campaña. Galeno (s. II d.C.). Tras el Edicto de Tesalónica (380, el cristianismo pasa a ser religión oficial) surgen los **xenodoquios** (hospicios), precursores de los hospitales.

Etapa vocacional (Edad Media y Edad Moderna)

- **Alta Edad Media**: San Benito de Nursia (s. VI) y la **Orden Benedictina**, con obligación de atender a enfermos. **Escuela de Salerno** (s. IX), que admitía mujeres. **Hôtel-Dieu** de París (s. VII). Cuidan a los enfermos diaconisas, agustinas y **beguinas** (mujeres laicas de Flandes).
- **Baja Edad Media** (Cruzadas): órdenes **militares** (Hospitalarios de San Juan de Jerusalén / Malta, San Lázaro), **mendicantes** (Franciscanos, Dominicos) y cofradías seglares.
- **Reforma Protestante**: cierra instituciones en el norte de Europa y abre la «**época oscura**» de la enfermería. Cuidan reclusas y mujeres marginales.
- **España, ss. XVI-XVII** (tras el Concilio de Trento): «**época áurea**» de la enfermería. Orden de **San Juan de Dios** (Juan Ciudad; aprobada por Pío V en 1572); **Ministros de los Enfermos** o Camilos (**Camilo de Lelis**, s. XVI, orden masculina); **Hijas de la Caridad** (Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, París, 1633). Aparecen los primeros manuales escritos por enfermeros.

Etapa técnica (s. XIX)

- **Elizabeth Fry** (Inglaterra, 1840): institución de formación para cuidadoras visitadoras.
- **Theodor Fliedner** (Alemania, 1836): Instituto de Diaconisas de **Kaiserswerth**, con formación de 3 años. Allí se forma Nightingale.
- **Florence Nightingale** (1820-1910): **madre de la enfermería moderna**.
- Guerra de **Crimea** (1854-56), hospital de **Scutari** (Turquía): reduce la mortalidad con higiene, nutrición y organización.
- ***Notes on Nursing*** (1859).
- **1860: primera escuela laica de enfermería, en el Hospital St. Thomas de Londres**.
- Primera enfermera investigadora: usa la **estadística** y los gráficos de áreas.

- **España**: antes había **practicantes** (hombres, curas menores), **matronas** (partos) y religiosas.
- **Ley Moyano** (Instrucción Pública, 1857): regula los títulos de practicante y matrona, pero **NO el de enfermera**.
- **Concepción Arenal** (escritora, desde 1860): defiende la reforma hospitalaria y propone unificar enfermera, practicante y matrona en un solo título y escuela.
- **1896: primera escuela de enfermería de España**, la **Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría** (Madrid, fundada por el doctor Federico Rubio).
- **1915, Real Orden: crea el título de Enfermera** en España, a instancias de las **Siervas de María**.

Etapa profesional (ss. XX-XXI): cronología España e internacional

Año	Hito
1899	Se funda el **Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)**, con código deontológico internacional. Su Plan Estratégico 2019-2023 tenía 3 ejes: **impacto global, liderazgo estratégico y crecimiento innovador**
1912	Colegios Oficiales de practicantes (en 1928 se incluyen las enfermeras)
1944	Colegio único de «Auxiliares Sanitarios»
1953	**Se unifican enfermera, practicante y matrona en el título de ATS** (Ayudante Técnico Sanitario)
1970	Ley General de Educación: dispone que la formación de ATS sea universitaria (se hace efectivo en 1977)
1977	**RD 2128/1977**: Escuelas Universitarias de Enfermería, **diplomatura de 3 años** (más de 4.500 h). Se crea el **Consejo General de Colegios de Enfermería**
1980	Curso de nivelación de ATS a **DUE** (Diplomado Universitario en Enfermería)
1999	Proceso de **Bolonia** (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES)
2005	**RD 450/2005** (Real Decreto de especialidades de Enfermería): **7 especialidades** vía **EIR** (Enfermero Interno Residente)
2007	**Grado en Enfermería (4 años)**, con acceso a máster y doctorado
2020	Bicentenario de Nightingale: la **OMS** (Organización Mundial de la Salud) declara el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona; campaña **Nursing Now** (OMS + CIE, 2018-2020) para dar más peso y liderazgo a las enfermeras
2021	**Desafío Nursing Now** (*Nursing Now Challenge*, OMS + CIE): continúa la campaña; busca **empoderar a enfermeras y matronas** para mejorar la experiencia del paciente y la salud

- **Las 7 especialidades (RD 450/2005)**: Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Salud Mental, Geriátrica, del Trabajo, Familiar y Comunitaria, Pediátrica y Cuidados Médico-Quirúrgicos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El Código de Hammurabi regula el ejercicio sanitario, pero **NO menciona la enfermería**.
! **La primera escuela laica fue St. Thomas (1860, Londres). Kaiserswerth (1836) era protestante (diaconisas).**
! La Ley Moyano (1857) **NO crea el título de enfermera**; eso llega en **1915**.
! «Época oscura» = países **protestantes**. «Época áurea» = **España** (ss. XVI-XVII).
! El CIE es de **1899**; el Consejo General de Colegios de Enfermería de España, de **1977**.

A2. La enfermería como disciplina y profesión

DISCIPLINA (la ciencia)	**PROFESIÓN** (la práctica)
Cuerpo de conocimientos científicos propios, generado por investigación y teorías	Ejercicio práctico de esos conocimientos para prestar un servicio específico a la sociedad
Se define por su marco conceptual, método científico y lenguaje propio	Se distingue por su autonomía, código ético y compromiso social (y, normalmente, retribución)

- «La teoría sin práctica está vacía y la práctica sin teoría es ciega.»
- **Kérouac** define la disciplina así: «la enfermera se interesa por el cuidado de la persona que, en interacción con su entorno, vive experiencias de salud» (contiene los 4 conceptos del metaparadigma).
- **Philip Elliott**: las profesiones con un cuerpo de conocimientos más teórico convencen mejor a la sociedad de que sus servicios son necesarios.

- Etapas del desarrollo del conocimiento: **curricular** (qué hacer), luego **investigación** (por qué funciona) y finalmente **teórica** (qué es la enfermería).

BLOQUE B · Modelos y teorías

B1. Jerarquía del conocimiento y metaparadigma

- De más abstracto a más concreto: **Filosofía, Ciencia, Disciplina, Paradigma, Metaparadigma** y, por último, **Modelos y Teorías**.
- **Paradigma**: corriente de pensamiento o manera de ver el mundo. **Metaparadigma**: el marco más global y abstracto de la disciplina.
- **Modelo vs teoría**: la diferencia principal es el **nivel de abstracción**. El modelo es más abstracto y global; la teoría es más concreta (describe, explica, predice o prescribe).

Metaparadigma enfermero: Jacqueline Fawcett

- Son 4 conceptos que toda teoría debe definir: **PERSONA, ENTORNO, SALUD y CUIDADO (ENFERMERÍA)** (**Fawcett**).
- **Persona**: quien recibe los cuidados (individuo, familia, grupo o comunidad).
- **Entorno**: condiciones externas físicas, sociales, culturales y psicológicas.
- **Salud**: un continuo que va del bienestar a la enfermedad y la muerte.
- **Cuidado**: las acciones propias de la enfermera.
- **Hernández Conesa**: critica que «enfermería» no es de la misma categoría lógica que los otros tres (son las acciones sobre ellos). Plantea relaciones persona-salud, persona-entorno, salud-cuidados y persona-entorno-salud.

Elementos comunes de los modelos

- **Supuestos**: premisas aceptadas sin demostración.
- **Sistema de valores**: lo que la teórica considera importante o deseable.
- **Principios**: meta de la enfermería, rol del profesional, origen del problema, enfoque de la intervención y consecuencias esperadas.
- **Criterios para evaluar teorías** (Fawcett; también Marriner-Alligood): **Claridad, Simplicidad (sencillez), Generalidad, Precisión empírica y Consecuencias deducibles**. Marriner-Tomey y Alligood analizaron 51 teorías con estos criterios.

B2. Clasificaciones de modelos y teorías (muy preguntado)

Paradigmas de Kérouac

	CATEGORIZACIÓN	INTEGRACIÓN	TRANSFORMACIÓN
Época	1850-1950 (raíces ss. XVIII-XIX)	1950-1975	1975 en adelante (**el actual**)
Visión	Fragmentada, causa única (influencia **positivista**). Persona = suma de partes	Multicausal; persona biopsicosocial e integrada	Fenómeno único, contextual e irrepetible; visión holística
Orientación	Salud pública (Nightingale) y enfermedad	Hacia la persona	Apertura al mundo
Cuidado	**«Hacer para»**; paciente pasivo	**«Actuar con»**	**«Estar con»**
Enfermera	Realizadora de tareas	Consejera	Compañera
Salud	Ausencia de enfermedad	Ideal, capacidad de adaptación	Valor y proceso
Teóricas	**Nightingale**	**Henderson, Orem, Peplau, Roy, Neuman, Johnson**	**Rogers, Watson, Leininger, Parse, Newman**

- Las escuelas del **Caring** y del **Ser humano unitario** (tabla siguiente) corresponden al paradigma de **Transformación**.

Escuelas de pensamiento (Meleis y Kérouac)

Escuela	Pregunta	Teóricas
Necesidades (influida por Maslow)	¿**Qué** hacen las enfermeras?	Henderson, Orem, Abdellah
Interacción	¿**Cómo** hacen lo que hacen?	Peplau, Orlando, King (Travelbee)
Efectos deseables	¿**Por qué** hacen lo que hacen?	Johnson, Roy, Neuman, Levine
Promoción de la salud	¿**A quién** van dirigidos los cuidados?	Moyra Allen, Nola Pender
Ser humano unitario	¿A quién? (visión holística y energética)	Rogers, Margaret Newman, Rizzo Parse
Caring	¿Cómo? (dimensión existencial y transpersonal)	Leininger, Watson, Benner

CLAVE PARA RECORDAR

- Truco: **Qué** = Necesidades; **Cómo** = Interacción o Caring; **Por qué** = Efectos deseables; **A quién** = Promoción de la salud o Ser unitario.

Tendencias

Autor (criterio)	Tendencia	Teóricas
Paul Beck (relación con la salud)	Ecologista (salud-naturaleza)	Nightingale
	Existencialista (salud-psicología)	Peplau, Roy, King, Levine
	Cósmica (salud-medio ambiente/energía)	Rogers, Neuman, Johnson
	Sociológica (salud-dinámica social)	Orem
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia; rol de la enfermera)	Naturalista	Nightingale
	Suplencia y ayuda	Henderson, Orem
	Interrelación	Peplau, Roy, Rogers, King, Levine
Marriner (significado de la enfermería)	Humanistas (arte y ciencia)	Nightingale, Henderson, Orem, Leininger, Watson
	Relaciones interpersonales	Peplau, Travelbee
	Sistemas	Johnson, Neuman
	Campos energéticos	Rogers

Nivel de abstracción: Marriner y Raile Alligood

Filosofías	Modelos conceptuales	Teorías	Teorías de nivel medio
Nightingale, Watson, Benner (Ray, Martinsen, Eriksson)	Orem, Rogers, Roy, King, Levine, Neuman, Johnson	Peplau, Leininger (Meleis, Newman, Parse)	Mercer, Mishel, Kolcaba, Pender, Beck. **Son las más útiles en la clínica**

- **Colley** (según su función, de menor a mayor desarrollo): descriptiva, explicativa, predictiva y prescriptiva.
- **Benavent** (4 orientaciones históricas): entorno (Nightingale), enfermedad, persona e interacción persona-entorno.

B3. Las teóricas que más caen

Florence Nightingale: Teoría del Entorno (1859)

- El **entorno** es su concepto central. La enfermedad es un **proceso reparador** de la naturaleza.
- La enfermera sitúa al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él.
- Salud: ausencia de enfermedad y capacidad de usar todos los recursos propios. Persona: **pasiva**.

- Componentes del entorno, con la regla «Vas Y Te Ríes De Henderson»: **Ventilación, Iluminación, Temperatura, Ruido, Dieta e Higiene**.
- Distingue la enfermería de la salud (prevención) y la enfermería del enfermo.
- Clasificación: paradigma de **Categorización** (salud pública). **No pertenece a ninguna escuela**, por ser pionera. Tendencia ecologista, naturalista y humanista.

Virginia Henderson: las 14 necesidades (1955)

- Definición aceptada por el **CIE**: «La única función de la enfermera es asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a su salud o recuperación (o a una muerte serena), que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios.»
- **Salud = independencia en la satisfacción de las necesidades**. El objetivo es la independencia lo antes posible.
- **Fuentes de dificultad (causas de la dependencia): falta de fuerza, de conocimiento o de voluntad**.
- Roles de la enfermera: **sustituta** (hace por él), **ayudante** (colabora) y **compañera** (fomenta la independencia).
- «Necesidad» no significa carencia, sino **requisito vital**.

1. Respirar normalmente	8. Higiene e integridad de la piel
2. Comer y beber adecuadamente	9. Evitar peligros del entorno (y no lesionar a otros)
3. Eliminar por todas las vías	10. Comunicarse con los demás
4. Moverse y mantener la postura	11. Vivir según sus creencias y valores
5. Dormir y descansar	12. Trabajar / realizarse
6. Vestirse y desvestirse	13. Actividades recreativas
7. Mantener la temperatura corporal	14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad

- Clasificación: paradigma de **Integración** (según Kérouac). Escuela de **Necesidades**. Tendencia de suplencia-ayuda y humanista.

Dorothea Orem: Teoría General del Autocuidado (década de 1960)

- Son **3 teorías** enlazadas:
- **Teoría del autocuidado**. Los requisitos de autocuidado (RAC) pueden ser **universales, del desarrollo o de desviación de la salud**.
- **Teoría del déficit de autocuidado (el núcleo)**: hay déficit cuando la **agencia de autocuidado** (capacidad) es menor que la **demanda de autocuidado terapéutico**. Ahí empieza la enfermería.
- **Teoría de los sistemas de enfermería**: **totalmente compensador (paciente inconsciente), parcialmente compensador (se comparte) y de apoyo-educación** (el paciente puede; la enfermera enseña y guía).
- **5 métodos de ayuda**: actuar por el paciente, guiarle, enseñarle, apoyarle y procurar un entorno favorable.
- Otros conceptos: **cuidado dependiente** (el que se da a otro dependiente) y **factores condicionantes básicos** (edad, sexo, estado de salud...).
- Salud: estado de totalidad estructural y funcional.
- Clasificación: paradigma de **Integración**. Escuela de **Necesidades**. Tendencia sociológica, de suplencia y humanista.

Hildegard Peplau: Relaciones Interpersonales (1952)

- «**Madre de la enfermería psiquiátrica**». Es el primer modelo centrado en la **relación enfermera-paciente**. Enfermería psicodinámica: un proceso interpersonal **terapéutico, significativo** y educativo.
- **4 fases (O-I-E-R): Orientación (se define el problema), Identificación (confianza), Explotación o aprovechamiento (usa los recursos) y Resolución** (se cierra el vínculo).
- **6 roles**: extraño, persona recurso, docente, líder, sustituto y **consejero** (el más importante).
- Salud: desarrollo de la personalidad hacia la madurez.
- Clasificación: paradigma de **Integración**. Escuela de **Interacción**. Tendencia existencialista, de interrelación e interpersonal.

Callista Roy: Modelo de Adaptación (1976)

- La persona es un **sistema adaptativo abierto**. Salud: proceso de ser y llegar a ser una persona integrada.
- **Estímulos**: **focal** (el inmediato), **contextuales** (el resto de los presentes) y **residuales** (efecto incierto: creencias, pasado).
- Mecanismos de afrontamiento: subsistema **regulador** (fisiológico) y subsistema **cognitivo** (psicosocial).
- **4 modos adaptativos: fisiológico, autoimagen o autoconcepto, dominio del rol e interdependencia**.
- La enfermera gestiona los estímulos para que la respuesta sea adaptativa.
- Clasificación: paradigma de **Integración**. Escuela de **Efectos deseables**. Tendencia existencialista y de interrelación.

Martha Rogers: Seres Humanos Unitarios (1970)

- La persona es un **campo de energía** irreductible, indivisible y pandimensional: un **sistema abierto** en interacción continua con otro sistema abierto, el entorno.
- 4 conceptos: campos de energía, universo de sistemas abiertos, patrones y pandimensionalidad.
- **Principios de homeodinámica**: **Resonancia** (cambios en los patrones de onda), **Helicidad** (cambio continuo, innovador e impredecible, en espiral) e **Integralidad** (interacción mutua persona-entorno).
- Intervenciones no invasivas: tacto terapéutico, música, luz, color, meditación.
- Clasificación: paradigma de **Transformación**. Escuela del **Ser humano unitario**. Tendencia cósmica y de campos energéticos.

Madeleine Leininger: Cuidados Culturales (Enfermería Transcultural)

- Primera enfermera doctorada en antropología y fundadora de la **enfermería transcultural**.
- El cuidado es universal, pero sus expresiones son diversas. Objetivo: **cuidados culturalmente congruentes**. Distingue cuidados genéricos o populares y profesionales.
- **3 modos de acción**: **conservación** o mantenimiento (prácticas beneficiosas), **adaptación** o negociación y **reestructuración** o reorientación (cambiar las prácticas nocivas). Modelo del **Sol Naciente**.
- Clasificación: paradigma de **Transformación**. Escuela del **Caring**. Tendencia humanista.

Jean Watson: Cuidado Humano / Transpersonal (1979)

- El cuidado (**caring**) es la esencia de la enfermería. Distingue **cuidado** (tarea de enfermería) y **curación** (tarea de la medicina).
- Persona: cuerpo, mente y alma. Salud: armonía entre mente, cuerpo y espíritu.
- **10 factores de cuidado** (*carative factors*), que evolucionaron a los procesos **caritas**. Ejemplos: sistema de valores humanístico-altruista, fe-esperanza, relación de ayuda-confianza, expresión de sentimientos y uso del método científico.
- Conceptos: **momento de cuidado** y **relación transpersonal**. Se basa en Maslow y en Carl Rogers.
- Clasificación: paradigma de **Transformación**. Escuela del **Caring**. Tendencia humanista.

Otras teóricas: lo esencial de cada una

Teórica	Modelo	Lo que preguntan
Myra Levine (1967)	Conservación	4 principios de conservación: energía, integridad estructural, integridad personal e integridad social. Escuela de Efectos deseables
Dorothy Johnson	Sistema conductual	**7 subsistemas**: afiliativo, dependencia, ingestión, eliminación, sexual, realización y agresivo-protector. Efectos deseables
Betty Neuman	Sistemas	Estresores (intra-, inter- y extrapersonales); líneas de defensa (flexible y normal) y **líneas de resistencia** (factores internos de protección frente al estresor); prevención en 3 niveles. Efectos deseables
Ida Jean Orlando	Proceso deliberativo	Necesidad inmediata; **validar** con el paciente y no inferir; acción deliberada, no automática. Interacción
Imogene King	Consecución de objetivos	Logro de metas mediante la interacción y las transacciones. Interacción

Teórica	Modelo	Lo que preguntan
Joyce Travelbee	Relación persona a persona	Encontrar **sentido al sufrimiento**
Faye G. Abdellah	Tipología de problemas	**21 problemas** de enfermería (evolución de Henderson). Necesidades
Patricia Benner (1984)	De principiante a experta	Basada en Dreyfus. **5 niveles: principiante, principiante avanzada, competente (2-3 años), eficiente y experta**. **Eficiente**: ve la situación como un todo, reconoce lo más importante y tiene un dominio intuitivo basado en su experiencia previa. **Experta**: ya no necesita reglas; actúa por intuición y va directa al problema. Know-how frente a know-that. Caring
Nola Pender (1982)	Promoción de la salud	Basada en **Bandura**: beneficios y barreras percibidas, **autoeficacia**, influencias interpersonales. Promoción de la salud
Roper-Logan-Tierney	Modelo de vida	**12 actividades** de la vida diaria (AVD)
Marjory Gordon	Patrones funcionales	**11 patrones funcionales** para la valoración
Kristen Swanson	Caring	5 procesos: conocer, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias
Merle Mishel	Incertidumbre	La incertidumbre ante la enfermedad influye en el afrontamiento
Katharine Kolcaba	Confort	Alivio, tranquilidad y trascendencia
Lydia Hall	Núcleo (esencia), cuidado y curación	3 círculos: cuidado (enfermera), núcleo (persona) y curación (equipo)
Ernestine Wiedenbach	El arte de cuidar (ayudar) en la enfermería clínica	La enfermera identifica la necesidad de ayuda del paciente, se la da y valida que la ha cubierto
Barbara Riegel	Autocuidado en la enfermedad crónica (nivel medio)	3 conceptos: **mantenimiento, monitorización y gestión** del autocuidado

TRAMPAS DE EXAMEN

- ! **Números que se cruzan: Henderson = 14 necesidades; Abdellah = 21 problemas; Gordon = 11 patrones; Roper = 12 AVD; Johnson = 7 subsistemas; Watson = 10 factores; Benner = 5 niveles; Peplau = 4 fases y 6 roles.**
- ! Henderson está en **Integración** (Kérouac), aunque su enfoque por necesidades «descompone» el cuidado. Si te preguntan el paradigma, marca Integración.
- ! Nightingale **no pertenece a ninguna escuela** (es la pionera).
- ! En Orem, el núcleo es la **teoría del déficit de autocuidado**. Sin déficit no hay intervención enfermera.
- ! Para Peplau, el rol más importante es el de **consejero**.
- ! Roy, estímulo **focal** = el inmediato. Rogers, **helicidad** = cambio en espiral e impredecible.

BLOQUE C · Constitución Española, organización territorial y Estatuto de Murcia

C1. La Constitución Española de 1978 (CE): datos básicos

Hito	Fecha
Aprobada por las Cortes	31 octubre 1978

Hito	Fecha
Referéndum (trampa: no es la entrada en vigor)	**6 diciembre 1978**
Sanción y promulgación por el Rey (la firma y ordena publicarla)	27 diciembre 1978
Entrada en vigor (publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE)	**29 diciembre 1978**

- **169 artículos**: Título Preliminar + 10 Títulos (11 en total; el Preliminar no lleva número).
- Al final lleva disposiciones **4-9-1-1**: 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
- Es una Constitución **rígida** (cambiarla exige mayorías reforzadas) y solo ha tenido **3 reformas**:
- **1992**: art. 13.2, para que los extranjeros de la Unión Europea puedan **ser elegidos** (sufragio pasivo) en las elecciones municipales, por el Tratado de Maastricht.
- **2011**: art. 135, estabilidad presupuestaria.
- **2024**: art. 49, «disminuidos» pasa a «**personas con discapacidad**».

Estructura por Títulos

Título	Contenido	Arts.
Preliminar	Principios básicos	1-9
I	**Derechos y deberes fundamentales**	**10-55**
II	La Corona	56-65
III	Cortes Generales	66-96
IV	Gobierno y Administración	97-107
V	Relaciones Gobierno-Cortes	108-116
VI	Poder Judicial	117-127
VII	Economía y Hacienda	128-136
VIII	**Organización territorial**	**137-158**
IX	Tribunal Constitucional	159-165
X	Reforma constitucional	166-169

Reforma constitucional (Título X)

- **Ordinaria (art. 167)**: reformas parciales.
- Requiere **3/5** de cada Cámara. Si Congreso y Senado no se ponen de acuerdo, una comisión paritaria (igual número de diputados y senadores) propone un texto.
- Si el Senado aprueba por mayoría absoluta sin llegar a 3/5, el Congreso puede aprobarla con **2/3**.
- Referéndum solo si lo pide **1/10** de los miembros de cualquier Cámara en **15 días**.
- **Agravada (art. 168)**: revisión total, Título Preliminar, arts. 15-29 (Sección 1.ª) o Título II (Corona).
- **2/3** de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por 2/3 de las nuevas Cámaras y **referéndum obligatorio**.

C2. Título Preliminar (arts. 1-9)

- **Art. 1**: España es un **Estado social y democrático de Derecho**.
- **Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político**.
- La soberanía nacional reside en el **pueblo español**.
- Forma política: **Monarquía parlamentaria**.
- **Art. 2**: la Nación española es una e indisoluble; reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.
- **Art. 3**: castellano oficial. Se tiene el **DEBER de conocerlo** y el **DERECHO a usarlo**.
- **Art. 4**: bandera roja-amarilla-roja; la amarilla es de doble anchura que cada una de las rojas.
- **Art. 5**: capital, la villa de Madrid.

- **Arts. 6 y 7**: partidos políticos (6), sindicatos y asociaciones empresariales (7); estructura y funcionamiento democráticos.
- **Art. 8**: Fuerzas Armadas = Ejército de Tierra, la **Armada** y el Ejército del Aire y del Espacio.
- **Art. 9.2**: los poderes públicos promueven que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
- **Art. 9.3**, principios garantizados:
- Legalidad, jerarquía normativa y publicidad de las normas.
- Irretroactividad (no se aplican hacia atrás) de las disposiciones sancionadoras **no favorables** o restrictivas de derechos individuales.
- Seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Los valores superiores son SOLO esos 4. «Solidaridad», «paz», «legalidad» o «democracia»: FALSO.**

! Art. 3: no inviertas los términos («derecho a conocerlo y deber de usarlo» es FALSO).

! Art. 8: «Marina» o «Ejército de Mar» es FALSO; es la **Armada**.

! Art. 9.3: la CE **NO** garantiza la irretroactividad de «todas» las disposiciones. Una norma sancionadora más favorable **SÍ** puede ser retroactiva.

C3. Título I: Derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55)

- **Art. 10**: la **dignidad de la persona** es fundamento del orden político y de la paz social.
- **Art. 10.2**: los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España.

Capítulo I: españoles y extranjeros (arts. 11-13)

- **Art. 12**: mayoría de edad a los **18 años**.
- **Art. 13**: la extradición se concede por tratado o ley (reciprocidad). Se excluyen los delitos políticos, pero el **terrorismo NO** se considera delito político.

Capítulo II: derechos y libertades (arts. 14-38)

- **Art. 14**: igualdad ante la ley y prohibición de discriminación (raza, sexo, religión, opinión...).
- Cuanto más protegido está un derecho, más difícil es cambiarlo y más vías hay para defenderlo. El **recurso de amparo** es la demanda que un ciudadano presenta ante el **Tribunal Constitucional** cuando le vulneran un derecho fundamental.
- Nombres oficiales (los cambian en el examen): Título I «**De los derechos y deberes fundamentales**»; Sección 1.ª «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas»; Sección 2.ª «De los derechos y deberes de los ciudadanos».

Sección 1.ª (arts. 15-29): Derechos fundamentales	**Sección 2.ª (arts. 30-38)**: Derechos y deberes de los ciudadanos
MÁXIMA protección: Ley Orgánica + recurso de amparo	Protección media: ley ordinaria, **SIN amparo**
15 Vida e integridad física y moral. Prohíbe la tortura. Pena de muerte abolida «salvo leyes penales militares en tiempo de guerra». Es el artículo de referencia en aborto y eutanasia	**30** Defensa de España. **30.2 Objeción de conciencia: SÍ tiene amparo** (excepción)
16 Libertad ideológica, religiosa y de culto; ninguna confesión es estatal (p. ej., el rechazo a transfusiones de los Testigos de Jehová)	**32** Matrimonio
17 Libertad. Detención preventiva máx. 72 h. *Habeas corpus*: llevar de inmediato ante el juez a quien está detenido ilegalmente	**33** Propiedad privada y herencia
18 Honor, intimidad y propia imagen; inviolabilidad del domicilio; secreto de comunicaciones (historia clínica, protección de datos)	**36** Colegios Profesionales, con estructura democrática
20 Libertad de expresión y cátedra; secreto profesional	
24 Tutela judicial efectiva (derecho a acudir a los jueces y obtener respuesta)	

Sección 1.ª (arts. 15-29): Derechos fundamentales	**Sección 2.ª (arts. 30-38)**: Derechos y deberes de los ciudadanos
27 Educación (básica obligatoria y gratuita)	

Capítulo III: principios rectores (arts. 39-52)

- **No se pueden reclamar directamente ante un juez**: son mandatos para que los poderes públicos hagan leyes y políticas. Solo se reclaman según lo que digan esas leyes. **No tienen amparo**.
- **Art. 39**: familia e infancia. **Art. 40.2**: seguridad e higiene en el trabajo (lo desarrolla la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). **Art. 41**: régimen público de Seguridad Social. **Art. 43**: protección de la salud. **Art. 47**: vivienda digna. **Art. 49**: personas con discapacidad (reforma de 2024). **Art. 50**: tercera edad (pensiones).

Capítulo IV: garantías (arts. 53-54)

- **Art. 53**: **el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional SOLO protege el art. 14, los arts. 15-29 y el art. 30.2**.
- **Art. 54**: **Defensor del Pueblo**, alto comisionado elegido por las **Cortes Generales**; defiende los derechos del Título I y supervisa a la Administración.

Capítulo V: suspensión de derechos (art. 55)

- **Suspensión general**: solo en estados de **excepción y sitio**. El estado de **alarma NO suspende** derechos fundamentales.
- **Suspensión individual**: en investigaciones de terrorismo o bandas armadas se puede alargar la detención más de 72 h o intervenir comunicaciones, con control posterior del Parlamento.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **«Un paciente en lista de espera recurre en amparo por el art. 43»: NO se admite. La salud es un principio rector, sin amparo.**

! El Defensor del Pueblo lo eligen las **Cortes Generales**, no el Rey ni el Gobierno.

! El art. **30.2** está en la Sección 2.ª pero **SÍ tiene amparo** (protege al sanitario objetor en aborto o eutanasia).

! Art. 49 actual: «personas con discapacidad». Si aparece «disminuidos» como redacción vigente: FALSO.

C4. Artículo 43: protección de la salud (pregunta fija)

- **43.1**: se reconoce el **derecho a la protección de la salud**.
- **43.2**: compete a los poderes públicos organizar y tutelar la **salud pública** mediante medidas preventivas y prestaciones; la ley fija derechos y deberes.
- **43.3**: los poderes públicos fomentan la **educación sanitaria**, la educación física y el deporte, y facilitan la adecuada utilización del ocio.
- Naturaleza: **principio rector (Cap. III) y derecho de configuración legal**: solo se puede exigir en los términos que fijen las leyes que lo desarrollan (y su presupuesto). **No tiene eficacia directa ni amparo**.

Ley	Clave
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS)	Crea el **Sistema Nacional de Salud (SNS)**: universal y financiado por impuestos. Sustituye al modelo anterior, en el que solo tenían asistencia los trabajadores asegurados (y los pobres, por beneficencia). Art. 3.1: prioridad a la **promoción de la salud y la prevención**
Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS	Evitar desigualdades entre Comunidades Autónomas (CCAA)
Ley 33/2011, General de Salud Pública	Vigilancia y protección de la salud de la población

C5. Las Cortes Generales (Título III, arts. 66-96)

- Son dos Cámaras, Congreso y Senado, pero el Congreso pesa más (**bicameralismo asimétrico**). Las Cortes son inviolables.
- Funciones: potestad **legislativa**, aprobar los **Presupuestos Generales del Estado** y **controlar al Gobierno**.
- **Congreso**: entre **300 y 400** diputados (la ley electoral los fija en **350**). Circunscripción: la **provincia** (+ Ceuta y Melilla). Mandato de 4 años.
- **Senado**: cámara de **representación territorial**. **4 senadores por provincia** peninsular + senadores designados por los parlamentos autonómicos. Mandato de 4 años.

Iniciativa legislativa

- **Proyecto de ley**: lo presenta el **Gobierno**. Tiene prioridad y se tramita directamente.
- **Proposición de ley**: la presentan el Congreso, el Senado, las Asambleas de las CCAA o la **iniciativa popular (500.000 firmas)**. Antes de tramitarse necesita la «toma en consideración» (una votación en la que la Cámara decide si la admite).
- El Senado tiene **2 meses** para vetar o enmendar (**20 días** si es urgente). La última palabra la tiene el **Congreso**.
- El Rey sanciona (firma) la ley en **15 días**; es un acto debido: no puede negarse.

Ley Orgánica (art. 81)	**Ley Ordinaria**
Derechos fundamentales y libertades públicas (15-29), Estatutos de Autonomía y régimen electoral	Todo lo demás
Mayoría absoluta del Congreso (176) en votación final sobre el conjunto del proyecto	Mayoría simple

Normas del Gobierno con rango de ley (muy preguntado)

Son normas que aprueba el Gobierno, no el Parlamento, pero tienen la misma fuerza que una ley.

	DECRETO-LEY (art. 86)	**DECRETO LEGISLATIVO (arts. 82-85)**
Motivo	**Extraordinaria y urgente necesidad**	**Delegación previa de las Cortes**
Control	**Posterior**: el Congreso lo convalida o deroga en **30 días**	**Previo**: las Cortes delegan antes, con una Ley de Bases (para redactar un texto articulado nuevo) o con una ley ordinaria (para refundir en un solo texto leyes que ya existen)
Límites	No puede afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni ley electoral	Materia concreta y plazo fijado. Prohibido subdelegar

> **CLAVE PARA RECORDAR**
>
> - Truco: en el decreto-ley el Gobierno «dispara primero» y el Parlamento revisa después. En el decreto legislativo el Parlamento autoriza primero y el Gobierno redacta después.

Plazos clave

Plazo	Qué es
72 horas	Detención preventiva (art. 17)
15 días	Sanción de las leyes por el Rey (art. 91)
20 días	Senado en proyectos urgentes
30 días	Convalidación de un decreto-ley por el Congreso
2 meses	Plazo ordinario del Senado / bloqueo de investidura (disolución y nuevas elecciones)

C6. El Gobierno y la Administración (Título IV, arts. 97-107)

- **Art. 97**: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
- Composición: Presidente, Vicepresidentes (si los hay), Ministros y demás miembros que fije la ley.

- **Ministros**: los nombra y separa el **Rey, a propuesta del Presidente**.

Investidura (art. 99)

- El Rey consulta a los grupos políticos y propone un candidato, que expone su programa ante el Congreso.
- 1.ª votación: **mayoría absoluta**. 2.ª votación (**48 h** después): **mayoría simple**.
- Si pasan **2 meses** desde la 1.ª votación sin investidura, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones.
- El candidato **NO necesita ser diputado**.

Cese y responsabilidad política

- Causas de cese: elecciones generales, dimisión o fallecimiento del Presidente, o pérdida de la confianza parlamentaria. Después sigue **en funciones**.
- **Cuestión de confianza**: la plantea el Presidente; se gana con **mayoría simple**.
- **Moción de censura**: la propone al menos **1/10 de los diputados (35)**, es **constructiva** (con candidato alternativo) y necesita **mayoría absoluta (176)**.

La Administración Pública

- **Art. 105.b**: acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (base del derecho de acceso a la **información pública**; no es un derecho fundamental).
- **Art. 103**: sirve con objetividad los intereses generales según los principios de **Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración y Coordinación**.
- **Ley 55/2003, Estatuto Marco** del personal estatutario de los servicios de salud: legislación básica estatal (art. 149.1.18 CE). Regula una relación de empleo especial, parecida a la de los funcionarios, y garantiza la movilidad en todo el SNS.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! «Los ministros los nombra el Presidente»: FALSO. Los nombra el **Rey a propuesta del Presidente**.
>
> ! Moción de censura con «mayoría simple»: FALSO. Requiere **mayoría absoluta**.
>
> ! **Art. 103: «Eficiencia» o «Centralización» son FALSAS. Es Eficacia.**

C7. Organización territorial del Estado (Título VIII, arts. 137-158)

- El Estado se organiza en **municipios, provincias y Comunidades Autónomas**, todos con autonomía para gestionar sus intereses.
- **Art. 138, solidaridad**: equilibrio económico entre territorios; los Estatutos no pueden crear privilegios económicos o sociales.
- **Art. 139, igualdad**: mismos derechos y obligaciones en todo el territorio; libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

CCAA: art. 148.1.21	**ESTADO (exclusiva): art. 149.1.16**
Sanidad e higiene: planificación sanitaria de su territorio y gestión de hospitales, centros de salud y asistencia diaria (Servicios de Salud como el Servicio Murciano de Salud, SMS)	1. **Sanidad exterior** (puertos, aeropuertos, fronteras) · 2. **Bases y coordinación general** de la sanidad · 3. **Legislación sobre productos farmacéuticos** (autorización, precio y financiación de medicamentos). También gestiona, a través del **INGESA** (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), la sanidad de Ceuta y Melilla

- **Art. 149.3, cláusula de supletoriedad**: lo que una comunidad no ha asumido en su Estatuto corresponde al Estado, y la ley estatal se aplica para cubrir lo que no regule la ley autonómica.

C8. Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia

- Es la **Ley Orgánica 4/1982**, aprobada el **9 de junio de 1982** (coincide con el Día de la Región).
- Acceso a la autonomía por el **art. 143 CE («vía lenta»)** (las competencias se asumen de forma gradual). Trampa: el art. 151 es el de Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña.

- Territorio (art. 2): los municipios de la provincia de Murcia.
- Bandera (art. 4): fondo **rojo carmesí**.
- Ángulo superior izquierdo: **4 castillos** de oro, de dos en dos.
- Ángulo inferior derecho: **7 coronas** reales en 4 filas, en orden 1-3-2-1.

Ciudad	Sede
Murcia	Capital de la Región, sede de la Presidencia y del Consejo de Gobierno
Cartagena	Sede de la **Asamblea Regional** (poder legislativo)

Reforma del Estatuto (Título VI)

- Iniciativa: **1/4** de la Asamblea Regional; **1/3 de los municipios** que representen la mayoría del censo; el Consejo de Gobierno; o el Gobierno de la Nación / Cortes Generales.
- Aprobación en la Asamblea: **3/5** de sus miembros.
- Si la reforma solo sirve para asumir nuevas competencias, basta con **mayoría absoluta**.
- Después se aprueba en las Cortes Generales como **Ley Orgánica**.

C9. La Asamblea Regional

- Ejerce la potestad legislativa; es inviolable (art. 21).
- Funciones (art. 22): legislar, aprobar los **Presupuestos regionales** (incluido el del SMS) y controlar al Ejecutivo.
- Sistema electoral tras la **reforma de 2015** (memorizar la tríada):
- **45 diputados**, con mandato de 4 años.
- **Circunscripción única** (toda la Región vota como un solo distrito; antes había 5).
- **Barrera electoral del 3 %** (votos mínimos para conseguir escaño; antes era del 5 %).
- Sede: **Cartagena**. Puede reunirse en otro lugar por acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces.

Órgano	Composición y función
Mesa	Presidente + 2 vicepresidentes + 2 secretarios. Dirige y administra la cámara. Vota por persona
Junta de Portavoces	Presidente + 1 portavoz por grupo. Fija el orden del día. **Voto ponderado** (cada portavoz vale tantos votos como diputados tiene su grupo)
Pleno	Los 45 diputados; órgano supremo
Comisiones	Trabajo especializado previo al Pleno (p. ej., Comisión de Sanidad)
Diputación Permanente	Actúa en vacaciones parlamentarias o tras la disolución

C10. Presidente de la Comunidad Autónoma (Ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno)

- Tiene la suprema representación de la Región y la representación ordinaria del Estado en ella, y preside el Consejo de Gobierno.
- El candidato lo propone el **Presidente de la Asamblea** tras consultar a los grupos, y **debe ser obligatoriamente Diputado Regional**.
- 1.ª votación: **mayoría absoluta (23)**. 2.ª votación (48 h después): **mayoría simple**.
- Si pasan **2 meses** sin elegir Presidente, la Asamblea se disuelve y se convocan elecciones.
- **Cese**: dimisión, **final de la legislatura** (cesa al acabar el periodo para el que se eligió la Asamblea), fallecimiento o incapacidad, condena firme que inhabilite, o pérdida de la confianza de la Asamblea. Sigue en funciones hasta que toma posesión el nuevo.
- Puede **delegar temporalmente** funciones ejecutivas en un Vicepresidente o Consejero.
- **Cuestión de confianza**: mayoría simple.
- **Moción de censura**: la propone **1/10** de la Asamblea (**5 diputados**), es constructiva y requiere **mayoría absoluta (23)**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **«Para ser Presidente del Gobierno de la Nación hay que ser diputado»: FALSO. «Para ser Presidente de Murcia hay que ser Diputado Regional»: VERDADERO.**

! «Capital de la Región» = **Murcia**. «Sede de la Asamblea / poder legislativo» = **Cartagena**.

! El voto ponderado se usa en la **Junta de Portavoces**, no en la Mesa.

! **Reforma electoral: 45 diputados, circunscripción única y barrera del 3 %. El 5 % y las 5 circunscripciones son trampa.**

C11. Consejo de Gobierno y Administración Regional

- **Consejo de Gobierno**: Presidente + Vicepresidentes + Consejeros. Tiene la función **ejecutiva** y la **potestad reglamentaria** (aprueba decretos y reglamentos).
- Los **Consejeros** los nombra y separa libremente el **Presidente**, sin votación en la Asamblea.
- **Ley 7/2004**, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia:
- Órganos **superiores**: Presidente, Vicepresidente y Consejeros.
- Órganos **directivos**: Secretarios Generales y Directores Generales.
- **Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia**: **crea el Servicio Murciano de Salud (SMS)**.
- Es un **Ente Público (entidad de Derecho Público) con personalidad jurídica propia**, patrimonio propio y plena capacidad de obrar.
- Está adscrito a la **Consejería de Salud** y gestiona Atención Primaria (AP), hospitales, Salud Mental y Urgencias.

C12. Instituciones consultivas y de control de Murcia

- **Consejo Jurídico**: máximo órgano consultivo en materia legal; emite dictámenes. Sede en Murcia; en protocolo va justo detrás del Consejo de Gobierno.
- **Consejo Económico y Social (CES)**: órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral; emite informes preceptivos sobre anteproyectos.
- **Comisionado de la Transparencia** (según el manual; lo regula la Ley 12/2014 de Transparencia de Murcia, ver tema 3): órgano unipersonal, sustituye al antiguo Consejo de la Transparencia (colegiado). Lo ratifica la Asamblea para 4 años.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **«El SMS es una Dirección General de la Consejería de Salud»: FALSO. Es un Ente Público con personalidad jurídica propia.**

! Director General y Secretario General son órganos **directivos**, NO superiores.

! Leyes regionales clave: **Ley 4/1994** de Salud de la Región de Murcia (crea el SMS), **Ley 6/2004** (Presidente y Consejo de Gobierno) y **Ley 7/2004** (Administración regional).